

Sistema de Gestão e Escala de Anestesia

Ficha de indicadores de qualidade e segurança em anestesia

FQA0002 · Concluída

1. IDENTIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO

Paciente	Prontuário	Data
EXEMPLO · Paciente Q02	EX-2001	22/09/2026
Cirurgia	Procedimento	Especialidade
CIR0018	Abdominoplastia	Cirurgia plástica
Unidade	Sala	Vínculo
Centro cirúrgico	Sala 2	Particular
Anestesiologista	Cirurgião	Caráter
Priscilla De Carli	Dr(a). Exemplo	Eletivo
Idade	Peso	Altura
31 anos	63 kg	161 cm
ASA	IMC	Técnica anestésica
II	24,3 kg/m²	Geral balanceada
Início da anestesia	Término da anestesia	Duração da anestesia
10:30	12:30	2h00
Entrada na SRPA	Saída da SRPA	Permanência na SRPA
12:38	13:45	1h07
Destino		
Enfermaria		

2. AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA

Avaliação documentada	Avaliação completa	Via aérea avaliada
Sim	Sim	Sim
Via aérea difícil prevista	Adesão ao protocolo de via aérea	Carrinho de via aérea disponível
Não	Não se aplica	Sim
Carrinho checado	Última ingestão	Tipo de ingestão
Sim	21/09/2026 21:30	Sólidos
Tempo de jejum		
13 h		

3. PERÍODO INTRAOPERATÓRIO — PROCESSO

Checklist realizado	Etapa de entrada	Pausa cirúrgica
Sim	Sim	Sim
Etapa de saída	Checklist completo	Pendências do checklist
Sim	Sim	—
Capnografia indicada	Capnografia utilizada	Motivo (se não)
Sim	Sim	—
Profilaxia antibiótica	Antibiótico	Horário do antibiótico
Sim	Cefazolina · 2 g	10:05
Horário da incisão	Antibiótico antes da incisão	Redose
11:00	55 min	Não se aplica
Profundidade indicada	Profundidade monitorizada	Dispositivo
Sim	Sim	BIS
Aquecimento ativo	Monitorização de temperatura	Bloqueador neuromuscular
Não	Sim	Sim
Monitorização neuromuscular	Método	Relação TOF
Sim	Aceleromiografia	0,95 às 12:28
Reversão do bloqueio	Medicamento da reversão	
Sim	Sugamadex · 2 mg/kg · 12:24	

3. PERÍODO INTRAOPERATÓRIO — MEDIDAS

Intubação traqueal	Menor SpO2	Tempo com SpO2 baixa
Sim	97%	0 min
Menor PAM	Tempo com PAM baixa	Maior PA sistólica
59 mmHg	7 min	141 mmHg

4. RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA

Temperatura na chegada	Náusea	Vômito
36,3 °C	Não	Não
Tratamento de náusea/vômito	Profilaxia indicada	Profilaxia realizada
—	Sim	Não
Medicamentos da profilaxia	Horários da profilaxia	Escala de dor
—	—	EVA (0–10)
Pontuação de dor	Tratamento da dor	Reavaliação da dor
3 às 12:42	—	—

5. EVENTOS CLÍNICOS — RESPOSTAS

Evento	Grupo	Resposta
Óbito em até 24 horas	Mortalidade e morbidade grave	Não
Óbito em até 48 horas	Mortalidade e morbidade grave	Não
Óbito em até 30 dias	Mortalidade e morbidade grave	sem informação
Parada cardiorrespiratória na sala cirúrgica	Mortalidade e morbidade grave	Não
Despertar intraoperatório com recordação explícita (suspeita ou confirmado)	Mortalidade e morbidade grave	Não
Disfunção neurológica perioperatória	Mortalidade e morbidade grave	Não
Intubação ou ventilação difícil	Mortalidade e morbidade grave	Não
Intubação esofágica	Complicações respiratórias	Não
Broncoaspiração pulmonar perioperatória	Complicações respiratórias	Não
Reintubação não planejada em até 24 horas	Complicações respiratórias	Não
Hipertensão grave no intraoperatório	Complicações cardiovasculares	Não
Isquemia ou infarto do miocárdio perioperatório	Complicações cardiovasculares	Não
Instabilidade hemodinâmica com vasopressor não planejado	Complicações cardiovasculares	Sim
Bloqueio neuromuscular residual (suspeita ou confirmado)	Outros desfechos clínicos	Não
Lesão de córnea	Outros desfechos clínicos	Não
Lesão relacionada ao posicionamento	Outros desfechos clínicos	Não
Falha de comunicação na passagem de cuidado	Transição de cuidado	Não

5. EVENTOS REGISTRADOS 1 registro(s)

1. Instabilidade hemodinâmica com vasopressor não planejado

Data e horário	Gravidade	Relação com a anestesia
22/09/2026 10:45	Moderada	Possível
Situação da investigação	Registrado por	Revisão clínica
Concluída	Anestesiista · demonstração	Confirmado · Dr(a). Revisor(a) Exemplo
Medicamento	Motivo	Intervenção realizada
Efedrina	Hipotensão após indução	Bolus e ajuste de anestésico inalatório

Descrição: Hipotensão após a indução (PAM 58) sem resposta à redução do halogenado.

Conduta: Efedrina 10 mg IV e redução do sevoflurano.

Evolução: PAM acima de 65 em 5 minutos, estável até o fim.

6. ACOMPANHAMENTO POSTERIOR

Janela	Situação	Data e hora	Por	Justificativa / observação
24 horas	Realizado	23/09/2026 10:00	Equipe de pós-operatório	
48 horas	Realizado	24/09/2026 10:00	Equipe de pós-operatório	
30 dias	pendente			

7. TRANSIÇÃO DE CUIDADO

Passagem registrada Sim	Destino SRPA	Horário 12:38
Transmitida por Priscilla De Carli	Recebida por Enf. Exemplo	Falha de comunicação Não

Informação essencial transmitida	Transmitida
Identificação do paciente e procedimento	sim
Antecedentes, alergias e comorbidades	sim
Técnica anestésica e via aérea	sim
Intercorrências do intraoperatório	sim
Fluidos, sangramento e diurese	sim
Fármacos administrados e horários	sim
Plano de analgesia	sim
Pendências e sinais de alerta	sim

7. SATISFAÇÃO DO PACIENTE

Pesquisa aplicada Sim	Instrumento Questionário de satisfação anestésica (exemplo)	Escala 0 a 10
Data 23/09/2026	Respondente Paciente	Nota 8,5

8. ESTRUTURA DA UNIDADE NO PERÍODO EST0011

Data 22/09/2026	Turno Manhã	Unidade Centro cirúrgico
Sala —	Carro de parada checado Sim	Sangue disponível Sim
Anestesiologistas 5	Salas em funcionamento 3	

Os dados de estrutura vêm do registro da coordenação, vinculado por data, unidade, sala e turno — não foram digitados nesta ficha.

10. REVISÃO CLÍNICA

Revisado por Dr(a). Revisor(a) Exemplo	Em 29/09/2026 15:14
---	------------------------

Parecer: Revisão de exemplo: registro conferido com o prontuário.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 107 registro(s)

Quando	Quem	Etap	Campo	De	Para
29/09/2026 15:14	demonstração	eventos	eventos	alterado	1 evento(s)
29/09/2026 15:14	demonstração	revisao	parecer	—	Revisão de exemplo: registro conferido com o prontuário.
29/09/2026 15:14	demonstração	revisao	revisadoEm	—	2026-09-29 15:14:16
29/09/2026 15:14	demonstração	revisao	revisadoPor	—	Dr(a). Revisor(a) Exemplo
29/09/2026 15:14	demonstração	ficha	status	Em preenchimento	Concluída

Quando	Quem	Etap	Campo	De	Para
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	isquemiaMiocardio	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	reintubacao24h	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	disfuncaoNeuro	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	despertar	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	obito48h	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	obito24h	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h48.por	—	Equipe de p
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h48.hora	—	10:00
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h48.data	—	2026-09-24
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h48.situacao	—	Realizado
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h24.por	—	Equipe de p
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h24.hora	—	10:00
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h24.data	—	2026-09-23
29/09/2026 15:14	demonstraça	seguimentos	h24.situacao	—	Realizado
29/09/2026 15:14	demonstraça	eventos	eventos	0	1
29/09/2026 15:14	demonstraça	satisfacao	nota	—	8.5
29/09/2026 15:14	demonstraça	satisfacao	respondente	—	Paciente
29/09/2026 15:14	demonstraça	satisfacao	data	—	2026-09-23
29/09/2026 15:14	demonstraça	satisfacao	escala	—	0 a 10
29/09/2026 15:14	demonstraça	satisfacao	instrumento	—	Question
29/09/2026 15:14	demonstraça	satisfacao	aplicada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstraça	transicao	itens	{ "identificacao": false, "antecedentes": false, "anestesia": false, "analgesia": false, "anticoagulacao": false, "antidoto": false, "antibiotico": false, "anticoagula	
29/09/2026 15:14	demonstraça	transicao	recebidoPor	—	Enf. Exemplo
29/09/2026 15:14	demonstraça	transicao	transmitidoPor	—	Priscilla De Carli
29/09/2026 15:14	demonstraça	transicao	hora	—	12:38
29/09/2026 15:14	demonstraça	transicao	destino	—	SRPA
29/09/2026 15:14	demonstraça	transicao	realizada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	falhaComunicacao	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	lesaoPosicionamento	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	lesaoCornea	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	bnmResidual	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	vasopressorNaoPlanejado	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	hipertensaoGrave	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	broncoaspiracao	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	intubacaoEsofagica	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	viaAereaDificil	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	respostas	pcrSala	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	dorHora	—	12:42
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	dorPontuacao	—	3
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	dorEscala	—	EVA (0–10)
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	profilaxiaNvFeita	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	profilaxiaNvIndicada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	vomito	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	nausea	—	N
29/09/2026 15:14	demonstraça	srpa	temperaturaChegada	—	36.3
29/09/2026 15:14	demonstraça	intra	pasMaxima	—	141

Quando	Quem	Etapas	Campo	De	Para
29/09/2026 15:14	demonstração	intra	minutosPamAbaixo	—	7
29/09/2026 15:14	demonstração	intra	pamMinima	—	59
29/09/2026 15:14	demonstração	intra	minutosSpo2Abaixo	—	0
29/09/2026 15:14	demonstração	intra	spo2Minima	—	97
29/09/2026 15:14	demonstração	intra	intubacao	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	bnmRevHora	—	12:24
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	bnmRevDose	—	2 mg/kg
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	bnmRevMedicamento	—	Sugamadex
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	bnmRevertido	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	tofHora	—	12:28
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	tofValor	—	0.95
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	bnmMetodo	—	Aceleromiografia
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	bnmMonitorizado	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	bnmUsado	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	monitorTemperatura	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	aquecimentoAtivo	—	Não
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	profundidadeDispositivo	—	BIS
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	profundidadeUsada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	profundidadeIndicada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	atbRedose	—	Não se aplica
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	incisaoHora	—	11:00
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	atbHora	—	10:05
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	atbDose	—	2 g
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	atbNome	—	Cefazolina
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	atbIndicada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	capnografiaUsada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	capnografiaIndicada	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	checklistCompleto	—	Sim
29/09/2026 15:14	demonstração	processo	checklistSaida	—	Sim

Anestesiologista responsável
Priscilla De Carli

Revisão clínica
Dr(a). Revisor(a) Exemplo